3.1.3.1. 통증관리

제 정 일	2008.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의료질향상 및 환자안전위원회				
유 관 부 서	마취통증의학과				

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 3.1.3 통증관리 JCI Standard 7th Edition: PCC.2.2, AOP.1.5, COP.6, ASC.5

제1조 (목적)

1. 환자가 겪는 통증이 환자에게 신체적, 정신적으로 영향을 주어 치료과정에 부정적인 결과를 초래하는 것을 예방하고, 환자의 통증 감소 및 안위 도모를 위해 통증이 관리되도록 통증에 대한 계획, 지지 그리고 치료를 제공하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 암성통증: 암세포의 침윤과 같이 암과 직접적으로 관련된 통증이나 약물 및 방사선 치료 등과 관련된 근육세포의 손상으로 인한 통증 등 암환자가 겪는 침해수용성 통증과 신경병증성 통증을 의미한다.
2. 소아청소년환자: 만 18세 이하(만 19세 미만) 환자
3. 노인환자: 만 65세 이상 환자

제3조 (절차)

1. 통증 초기평가
   1) 환자가 입원 시, 외래 및 응급진료센터 내원 시 통증 스크리닝을 시행한다.
   2) 통증 호소 시 통증 초기 평가를 시행한다.
   3) 입원환자는 통증이 없는 경우에도 1일 1회 통증유무확인을 시행한다.
   4) 통증 평가
      (1) 통증의 부위, 강도, 양상, 빈도, 지속기간 등을 평가한다.
      (2) 필요 시 악화요인, 완화요인, 동반질환, 지금까지 받아온 통증치료와 효과 등을 평가한다.

2. 통증평가 도구
   1) 만 3세 미만 환자, 의사소통이 불가능한 소아청소년환자, 무의식 소아청소년환자
      (1) FLACC(Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) Pain Scale
   2) 만 3세 이상 의사소통이 가능한 환자
      (1) NRS(Numeric Rating Scale) / NPIS(Numerical Pain Intensity Scale)
      (2) VAS(Visual Analog Scale)
      (3) Wong-Baker Faces Pain Rating Scale
   3) 신생아

(1) CRIES Scale(Crying, Requires oxygen, Increased vital sign, Expression of face, Sleeplessness)

4) 의사소통이 불가능한 성인 환자, 무의식 성인 환자

(1) CPOT(Critical-Care Pain Observation Tool)

3. 통증관리

1) 통증평가 후 통증점수가 1점 이상이고, 환자의 요구가 있는 경우 적절한 관리(약물적 중재, 비약물적 중재 등)를 시행한다.

2) 흉통 호소 환자는 즉각적인 평가와 중재를 시행한다.

3) 환자 및 보호자에게 검사, 수술/시술, 치료과정에 따른 통증의 발생가능성을 설명하고 통증관리 방법을 교육한다.

4. 통증 재평가

1) 방법: 통증중재 방법, 통증의 부위, 강도, 양상, 빈도, 지속기간 등을 평가한다.

2) 재평가 시기

(1) 환자 상태변화 시

(2) 주사투여: 투약 후 30분 이내 평가

(3) 주사제 마약성 진통제는 투약 후 15분 이내 평가

(4) 경구투여: 투약 후 1시간 이내 평가(경구제 마약성 진통제는 투약 후 1시간 이내 평가)

(5) 흉통에 대해 약물 중재 적용 시: 투약 후 5분 이내 평가

(6) 통증에 대한 비약물적 중재 적용 시: 중재 후 1시간 이내 평가

(7) 수술, 침습적 처지 후: 당일 평가

(8) 통증에 대한 지속적 치료적 중재 적용 시: 1일 2회 평가

① PCA (Patient Controlled Analgesia) 적용 환자는 1일 2회 부작용 등을 포함하여 통증평가를 시행한다.

5. 암성통증 환자 통증관리

1) 질병력, 정신사회적 문제, 통증이나 통증조절에 대한 잘못된 믿음, 통증원인 등 포괄적인 통증평가를 시행한다.

2) 암성통증의 재발을 예방하기 위해 진통제를 일정한 간격 또는 지속적으로 투여한다.

3) 필요 시 마취통증의학과, 방사선종양학과 등 다학제적 전문가들의 평가와 중재를 시행한다.

4) 필요 시 진통제의 부작용을 최소화하기 위해 변비약, 항구토제 등의 투여를 병행한다.

6. 통증평가와 관리 시 환자의 요구를 고려하고 권리를 존중한다.

7. 의료진은 통증관리 관련 교육을 받는다.

제4조 (부록)

1. 통증평가 도구

2. 통증 중재 순서도

제5조 (참고)

1. Serlin RC, Mendoza TR, Nakamura Y, et al. When is cancer pain mild, moderate, or severe? Grading pain severity by its interference with function. Pain. 1995;61: 277-284
2. Collins SL, Moore RA, McQuay HJ. The visual analogue pain intensity scale: what is moderate pain in millimetres? Pain. 1997; 72: 95–7.
3. Harris JT, Suresh Kumar K, Rajagopal MR. Intravenous morphine for rapid control of severe cancer pain. Palliat Med 2003;17: 248-256
4. Gordon DB, Dahl JL, Miaskowski C, McCarberg B, Todd KH, Paice JA, Lipman AG, Bookbinder M, Sanders SH, Turk DC, Carr DB. American pain society recommendations for improving the quality of acute and cancer pain management: American Pain Society Quality of Care Task Force. Arch Intern Med. 2005; 165(14): 1574-80.
5. Jones KR, Vojir CP, Hutt E, Fink R. Determining mild, moderate, and severe pain equivalency across pain-intensity tools in nursing home residents. J Rehabil Res Dev. 2007; 44(2): 305-14.
6. Breivik H, Borchgrevink PC, Allen SM, Rosseland LA, Romundstad L, Hals EK, Kvarstein G, Stubhaug A. Assessment of pain. Br J Anaesth. 2008; 101(1): 17-24.
7. American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management; American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Practice guidelines for chronic pain management: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Chronic Pain Management and the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine. Anesthesiology. 2010; 112(4): 810-33.
8. 암성 통증관리지침 권고안 7판. 보건복지부

내규의 제·개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2008년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)